SHIP IT — 2부 12화

The Protocol (임상시험 계획서)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 2부 12화 · 서사 기능: IDE 조건부 승인, 핵심 임상 설계 확정
> - 배경: 11화 6주 뒤 8월 넷째 주 목요일 오전 9시, 노스 오스틴 Veyra 첫 독립 사무실(7월 입주) 회의실 → 오후 2시 같은 곳(통계 컨설턴트 화상 참여) → 오후 6시
> - 등장인물: Noah, Elena, Priya, Marcus, Grace, Leo, Dr. Paul Novak(생물통계 컨설턴트), Richard(전화)
> - 비즈니스 스킬: 공식 서한 읽고 이해하기, 기술 문서 논의, 용어 정의 합의
> - 난이도: B1+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 15단어 이내 + 긴 턴 10~15회(25~35단어). (FDA 서한 낭독 1회 예외)
> - 복선 설치: IDE 조건부 승인(30일 심사) — 조건 3가지(하위 연구 효소 용량 근거, 동의서 수정, 혈관 사건 중단 기준 + 독립 DSMB) · 피험자 300명 1:1 무작위, 비교 제품 = Lumaderm Volume(Noah의 옛 제품) · 1차 평가변수: 6개월 주름 개선 반응률, 비열등성 · 용해 하위 연구 40명(같은 응급 용량) · “Not worse” ≠ “better” · 첫 환자 목표 11월 · 사무실 이전(Capital BioWorks 졸업) · Richard: “Start your Series A now.”(→2부 13화)

대본

도입 — 새 사무실, 오전 9시: FDA 서한

GRACE It’s here. The FDA letter. Day thirty, exactly.

MARCUS Thirty days. They’re never late. I respect that.

NOAH Elena, read it. I can’t look.

ELENA “Your IDE application is approved with conditions. You may begin enrollment once the conditions are addressed.”

PRIYA Approved! With conditions, but approved!

LEO Is “with conditions” good or bad?

GRACE It’s normal, so don’t worry. Most IDEs come with conditions. It means ‘yes, but fix these first.’ If the FDA had serious concerns, the letter would say no, not yes.

MARCUS How many conditions?

ELENA Three. None of them surprising.

NOAH Our first FDA approval. Of anything.

LEO In our first real office. Without a shared autoclave.

MARCUS Rita cried when we left. Then she sent us a bill for the last month.

PRIYA The edible packaging people still send us snacks on Fridays.

ELENA Okay. Let’s read the conditions carefully. Word by word.

NOAH Then design the trial. Today. Paul joins at two.

장면1 — 세 가지 조건

ELENA Condition one. “Justify the hyaluronidase dose in the dissolution substudy.”

PRIYA We said “emergency dose.” They want to know why that number.

GRACE They want references. What doctors actually use in emergencies.

ELENA I can write that. With published guidelines. And my own experience.

MARCUS Your experience counts as evidence?

ELENA Guidelines are evidence. My experience is context. Both help.

NOAH Condition two?

ELENA “Revise the informed consent form. Clearly explain the substudy procedures and risks.”

LEO Informed consent. The form patients sign before joining?

GRACE Right. And our substudy is unusual, because we inject filler and then dissolve it on purpose. Patients need to understand that before they sign, or the consent isn’t really informed.

PRIYA So patients get an injection that disappears. That needs a very clear explanation.

ELENA In plain language. Eighth-grade reading level. That’s the standard.

NOAH Eighth grade. That’s my kind of writing.

MARCUS Finally, a job for the marketing guy.

ELENA Actually, yes. Noah, you’ll draft it. Then I’ll check every medical word.

NOAH Clear, honest, no selling. Got it.

ELENA Condition three. “Add stopping rules for vascular events. And an independent DSMB.”

MARCUS DSMB. Acronym fifty-two. Translate.

GRACE Data Safety Monitoring Board. Independent experts who watch the safety data during the trial.

LEO Independent from us?

GRACE Completely independent. They see the safety data during the trial, and they can recommend stopping it, even if we disagree. That’s exactly why the FDA trusts them more than us.

PRIYA Like Elena’s veto. But outside the company.

ELENA Exactly. I welcome it. More eyes on safety is never bad.

NOAH And stopping rules? What does that mean in practice?

ELENA We decide in advance. For example, if a certain number of occlusions happen, we pause enrollment and review every case before anyone gets another injection. No debate, no pressure.

MARCUS Decided before anyone is emotional. Smart.

GRACE That’s the whole point. Rules made calmly, used in a storm.

NOAH What number should trigger a pause?

ELENA The DSMB will help us decide. With the statistician.

PRIYA How long do we have to respond?

GRACE There’s no fixed deadline. But every week of delay pushes the first patient back, and our costs don’t stop. So the faster we answer, the cheaper this gets.

MARCUS Two weeks. Let’s commit to two weeks.

ELENA Two weeks is possible. If nobody goes on vacation.

LEO My vacation is a three-month-old. She doesn't let me sleep anyway.

NOAH Okay. Two weeks. Now the big part. The protocol itself.

장면2 — 통계 컨설턴트 Paul Novak

NOVAK Good afternoon. Paul Novak. Can you all see me?

GRACE We see you, Paul. Thanks for joining. Everyone, Paul is our biostatistician.

NOVAK Let's start with the basic design. Three hundred patients. One-to-one randomization.

MARCUS One-to-one. Half get Veyra, half get the comparator?

NOVAK Exactly. A computer decides who gets what. Not the doctor.

LEO Why not the doctor?

NOVAK Because doctors might give the new product to the 'easier' patients, without even meaning to. Then the results look better than they really are, and the whole study loses its value.

ELENA That's called bias. Randomization removes it.

NOVAK Now, the comparator. Which approved filler?

ELENA The market leader. Lumaderm Volume.

NOAH Lumaderm. My old product.

PRIYA The product that was in Lily's nose.

ELENA It's the standard of care. Doctors know it. The FDA knows it.

NOAH I know, and it's the right choice. It just feels strange. I spent four years selling Lumaderm, and now we're buying Halvern's product so we can test against it.

MARCUS Is that legal? Using a competitor's product?

GRACE Completely. We buy it at market price. Like any clinic would.

NOVAK The primary endpoint. Wrinkle improvement at six months.

ELENA Measured on the standard five-point scale. By blinded evaluators.

NOVAK And a "responder" is a patient who improves at least one point.

PRIYA So we compare the percentage of responders. Veyra versus Lumaderm.

NOVAK Correct. And the design is non-inferiority.

NOAH Non-inferiority. In plain English?

NOVAK We show Veyra is not worse than Lumaderm. Within a small margin.

NOAH Not worse? Why not prove it's better?

NOVAK For wrinkles, both products work well, so the difference would be small. Proving 'better' would need thousands of patients, and that means years and money you don't have.

ELENA Our advantage isn't wrinkles. It's dissolution. That's the substudy.

NOVAK Exactly. Main study: equal on wrinkles. Substudy: faster to dissolve.

GRACE How many patients in the substudy?

NOVAK Forty. Twenty per arm. Same emergency dose for both.

PRIYA Forty patients. Enough to see the difference?

절정·전환 — “Not worse” vs. “Better”

NOVAK If the difference is as big as your animal data, yes. Easily.

NOAH Can I push back on something? About the main study?

NOVAK Please.

NOAH Here’s the thing. ‘Not worse than Lumaderm’ is a weak message. I sat with doctors for four years, and nobody gets excited about ‘not worse.’ They want ‘better.’

ELENA Noah, this is science. Not marketing.

NOAH I know. But eventually it becomes marketing. Someone has to sell it.

PRIYA Then sell what’s true. “Same results. Plus an emergency exit.”

NOVAK That’s actually a strong message. And you can prove both parts.

MARCUS “Same, plus.” I like that. Simple.

NOAH “Same results, plus an emergency exit.” Okay. That I can sell.

ELENA And remember Dr. Park. “Faster” is a measurement. We’ll have the measurement.

NOVAK One warning. If you design for non-inferiority, you can’t claim superiority later.

NOAH Even if our numbers look better?

NOVAK Even then. You decide the question before you see the answer. If you change the question after the data comes in, regulators will assume you went looking for a good story.

GRACE That’s the rule. Otherwise anyone could pick the story after the data.

PRIYA Like group three.

NOAH Like group three. Okay. I learned that lesson already.

NOVAK Then let’s lock it. Primary: non-inferiority at six months. Secondary: twelve-month durability.

ELENA And key secondary: dissolution speed in the substudy.

NOVAK Plus safety. Every adverse event, both arms.

MARCUS How many sites again?

GRACE Fifteen. Rachel Stein’s clinic is site one.

LEO When’s the first patient?

GRACE If we respond in two weeks, and sites are trained, mid-November.

NOVAK Send me the final protocol by Monday. I’ll run the sample size again.

마무리 — 오후 6시, Richard의 전화

NOAH Richard, good news. The IDE was approved. With three conditions.

RICHARD Conditions are normal. Congratulations. When’s the first patient?

NOAH Mid-November. Three hundred patients. Fifteen sites.

RICHARD And the trial costs twelve point six million, while you have about four left. So even if everything goes perfectly, the money runs out long before the trial ends.

NOAH I know. About four. Yes.

RICHARD Then you know what I'm going to say.

NOAH Series A.

RICHARD Start your Series A now. Not after the first patient. Now.

NOAH Why now? We'd have more data in three months.

RICHARD Raise money when you don't need it, because investors can smell desperation. When you really need it, it's too late, and they get to set the price for you.

NOAH How much should we raise?

RICHARD Enough to finish the trial. And submit the PMA. Twenty-five million.

NOAH Twenty-five million. Will Northgate lead?

RICHARD We'll invest. But a bigger fund should lead. Two firms already called me about you.

NOAH Two firms. Then I'd better bring my best deck.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	approved with conditions	조건부 승인	도입. "Yes, but fix these."
2	Word by word.	한 단어씩.	도입. 공식 문서를 꼼꼼히 읽자고 할 때.
3	Guidelines are evidence. Experience is context.	가이드라인은 증거, 경험은 맥락이다.	장면1. 근거의 수준을 구분하는 표현.
4	informed consent	(충분한 설명에 근거한) 동의	장면1. 임상 윤리의 핵심. 쉬운 말로 쓰는 것이 원칙이다.
5	stopping rules	중단 기준	장면1. 미리 정해 두는 임상 일시 중지 조건.
6	Rules made calmly, used in a storm.	차분할 때 만든 규칙을 폭풍 속에서 쓴다.	장면1. 사전 규칙의 가치를 설명할 때.
7	randomization / bias	무작위 배정 / 편향	장면2. 공정한 비교의 기본.
8	non-inferiority	비열등성("나쁘지 않음")	장면2. 신제품이 기존 제품보다 열등하지 않음을 보이는 설계.
9	Same results. Plus an emergency exit.	같은 효과, 거기에 비상구까지.	절정·전환. 증명 가능한 사실로 만든 마케팅 메시지.
10	Raise money when you don't need it.	돈은 필요하지 않을 때 모아라.	마무리. 스타트업 자금 조달의 격언.

② 비즈니스 컬처 노트 — 질문은 답을 보기 전에 정한다

임상시험에서는 1차 평가변수와 통계 분석 방법을 데이터를 보기 전에 계획서(protocol)에 고정한다. 결과를 본 뒤 유리한 질문을 고르면 “p-hacking”이나 체리피킹이 되기 때문이다. 그래서 비열등성(non-inferiority)으로 설계한 연구로는 나중에 “더 좋다(superior)”고 주장할 수 없다. 이 원칙은 비즈니스 일반에도 통한다. A/B 테스트, 성과 지표(KPI), 파일럿 프로젝트의 성공 기준을 시작 전에 정해 두면 결과 해석을 둘러싼 논쟁이 줄어든다.

③ 실무 템플릿 — 연구 설계 한 문단 요약 (Study Design Summary)

> Design: [randomized / controlled / blinded], [N] patients, [ratio] randomization, [sites] sites. Comparator: [product]. Primary endpoint: [measure] at [time], tested for [non-inferiority / superiority]. Key secondary endpoints: [list]. Safety oversight: [DSMB, stopping rules].

예시: > *A randomized, evaluator-blinded, controlled trial of 300 patients at 15 sites, randomized 1:1 to Veyra Fill or Lumaderm Volume. Primary endpoint: wrinkle improvement responder rate at six months, tested for non-inferiority. Key secondary endpoints: twelve-month durability and dissolution speed in a 40-patient substudy. Safety is overseen by an independent DSMB with predefined stopping rules.*

④ 긴 발화 분석

> ELENA (장면1): “We decide in advance. For example, if a certain number of occlusions happen, we pause enrollment and review every case before anyone gets another injection. No debate, no pressure.”

구조	영어	기능
① 정의(핵심 한 줄)	We decide in advance.	낯선 용어(stopping rules)를 한 문장으로 정의
② 예시(조건)	For example, if a certain number of occlusions happen,	For example + if로 추상 개념을 구체적 상황으로 바꿈
③ 행동(절차)	we pause enrollment and review every case before anyone gets another injection.	조건이 충족되면 무엇을 하는지 순서대로 설명
④ 효과(요약)	No debate, no pressure.	짧은 명사구 두 개로 규칙의 가치를 압축

활용 패턴: 한 줄 정의 → For example, if… → 그러면 하는 행동 → 짧은 요약 연결 표현: in advance(미리) · For example(예를 들어) · before anyone…(누구든 ~하기 전에) 연습: 팀에 ’배포 중단 기준’을 처음 설명하는 상황에서 같은 구조로 30단어 안팎으로 말해 보기.

한국어 번역

도입 — 새 사무실, 오전 9시: FDA 서한

그레이스 왔어요. FDA 서한. 정확히 30일째.

마커스 30일. 절대 안 늦지. 그건 존경해.

노아 엘레나, 읽어 줘요. 못 보겠어요.

엘레나 "귀사의 IDE 신청은 조건부로 승인되었습니다. 조건을 해결하면 피험자 등록을 시작할 수 있습니다."

프리야 승인! 조건부지만, 승인이야!

레오 "조건부"는 좋은 거예요, 나쁜 거예요?

그레이스 정상이에요, 걱정 마세요. 대부분의 IDE는 조건이 붙어요. "네, 하지만 이것들부터 고치세요"라는 뜻이죠. FDA가 심각한 우려를 가졌다면 서한에 '예'가 아니라 '아니요'라고 썼을 거예요.

마커스 조건이 몇 개야?

엘레나 세 개요. 놀라운 건 하나도 없어요.

노아 우리의 첫 FDA 승인이네요. 뭐가 됐든.

레오 우리 첫 진짜 사무실에서. 공용 멸균기 없이.

마커스 우리가 나올 때 리타가 울었어. 그러고 마지막 달 청구서를 보냈지.

프리야 먹는 포장재 사람들은 아직도 금요일마다 간식 보내 줘요.

엘레나 좋아요. 조건을 꼼꼼히 읽어 봐요. 한 단어씩.

노아 그다음 임상을 설계하죠. 오늘. 폴이 2시에 들어와요.

장면1 — 세 가지 조건

엘레나 조건 하나. "용해 하위 연구의 히알루로니다아제 용량 근거를 제시할 것."

프리야 우리가 "응급 용량"이라고 했잖아. 왜 그 숫자인지 알고 싶은 거야.

그레이스 참고 문헌을 원해요. 의사들이 응급 상황에 실제로 쓰는 용량이요.

엘레나 그건 내가 쓸 수 있어요. 발표된 가이드라인이랑 내 경험으로.

마커스 선생님 경험도 증거로 인정돼요?

엘레나 가이드라인은 증거고, 내 경험은 맥락이에요. 둘 다 도움이 돼요.

노아 조건 둘은요?

엘레나 "동의서를 수정할 것. 하위 연구 절차와 위험을 명확히 설명할 것."

레오 동의서. 환자들이 참여 전에 서명하는 서류요?

그레이스 맞아요. 그리고 우리 하위 연구는 특이해요. 필러를 주입한 다음 일부러 녹이거든요. 환자들이 서명하기 전에 그걸 이해해야 해요. 안 그러면 진짜 '설명 후 동의'가 아니에요.

프리야 그러니까 환자들은 사라질 주사를 맞는 거네요. 아주 명확한 설명이 필요하겠어요.

엘레나 쉬운 말로요. 중학교 2학년 독해 수준. 그게 기준이에요.

노아 중학교 2학년. 제가 잘 쓰는 수준이네요.

마커스 드디어 마케팅 담당이 할 일이 생겼네.

엘레나 사실 맞아요. 노아, 초안을 써요. 그다음 내가 의학 용어를 전부 확인할게요.

노아 명확하게, 정직하게, 팔지 않게. 알겠어요.

엘레나 조건 셋. "혈관 관련 사건에 대한 중단 기준을 추가할 것. 그리고 독립 DSMB."

마커스 DSMB. 약자 52번. 번역해 줘.

그레이스 데이터 안전성 모니터링 위원회요. 임상 중에 안전성 데이터를 지켜보는 독립 전문가들이에요.

레오 우리로부터 독립적이라는 거예요?

그레이스 완전히 독립적이에요. 임상 중에 안전성 데이터를 보고, 우리가 반대해도 임상 중단을 권고할 수 있어요. 바로 그래서 FDA가 우리보다 그들을 더 신뢰하는 거죠.

프리야 엘레나의 거부권 같네요. 다만 회사 밖에 있는.

엘레나 바로 그거예요. 환영해요. 안전을 보는 눈이 많아서 나쁠 건 없어요.

노아 그리고 중단 기준은요? 실제로는 무슨 뜻이에요?

엘레나 미리 정하는 거예요. 예를 들어 혈관 폐색이 일정 건수 이상 생기면, 누구에게든 다음 주사를 놓기 전에 등록을 일시 중지하고 모든 사례를 검토해요. 논쟁도, 압박도 없이요.

마커스 누가 감정적이 되기 전에 정해 둔다. 현명하네.

그레이스 그게 핵심이에요. 차분할 때 만든 규칙을 폭풍 속에서 쓰는 거죠.

노아 몇 건이면 일시 중지해야 해요?

엘레나 DSMB가 결정을 도와줄 거예요. 통계 전문가랑 같이.

프리야 답변 기한이 얼마나 돼요?

그레이스 정해진 기한은 없어요. 하지만 일주일 늦어질 때마다 첫 환자 시점이 밀리고, 비용은 계속 나가요. 그러니까 빨리 답할수록 돈이 덜 들어요.

마커스 2주. 2주로 약속하자.

엘레나 2주는 가능해요. 아무도 휴가를 안 간다면요.

레오 제 휴가는 생후 3개월짜리예요. 어차피 잠을 안 재워 줘요.

노아 좋아요. 2주. 이제 큰 부분이요. 프로토콜 자체.

장면2 — 통계 컨설턴트 Paul Novak

노박 안녕하세요. 폴 노박입니다. 다들 저 보이세요?

그레이스 보여요, 폴. 들어와 줘서 고마워요. 여러분, 폴은 우리 생물통계 전문가예요.

노박 기본 설계부터 시작하죠. 환자 300명. 1:1 무작위 배정.

마커스 1:1. 절반은 Veyra, 절반은 비교 제품?

노박 맞아요. 누가 뭘 받을지는 컴퓨터가 정해요. 의사가 아니라.

레오 왜 의사가 정하면 안 돼요?

노박 의사는 의도치 않게 “쉬운” 환자에게 신제품을 줄 수 있거든요. 그러면 결과가 실제보다 좋아 보이고, 연구 전체가 가치를 잃어요.

엘레나 그걸 편향이라고 해요. 무작위 배정이 그걸 없애요.

노박 자, 비교 제품. 어느 승인 필러로 할까요?

엘레나 시장 1위요. 루마덤 볼륨.

노아 루마덤. 제 옛 제품이네요.

프리야 릴리 코에 들어갔던 그 제품.

엘레나 표준 치료예요. 의사들도 알고, FDA도 알아요.

노아 알아요, 옳은 선택이에요. 그냥 기분이 이상해서요. 4년 동안 루마덤을 팔았는데, 이제 그걸 상대로 시험하려고 할번 제품을 사는 거잖아요.

마커스 그거 합법이야? 경쟁사 제품을 쓰는 게?

그레이스 완전히요. 시장 가격으로 사요. 다른 병원들처럼요.

노박 1차 평가변수. 6개월 시점 주름 개선.

엘레나 표준 5점 척도로 측정해요. 눈가림된 평가자가요.

노박 그리고 “반응자”는 최소 1점 이상 개선된 환자를 말해요.

프리야 그러니까 반응자 비율을 비교하는 거네요. Veyra 대 루마덤.

노박 맞아요. 그리고 설계는 비열등성이에요.

노아 비열등성. 쉬운 말로요?

노박 Veyra가 루마덤보다 나쁘지 않다는 걸 보여 주는 거예요. 작은 허용 범위 안에서.

노아 나쁘지 않다? 왜 더 좋다는 걸 증명하지 않아요?

노박 주름에는 두 제품 다 잘 들어서 차이가 작을 거예요. “더 좋다”를 증명하려면 환자가 수천 명 필요하고, 그건 여러분에게 없는 몇 년의 시간과 돈을 뜻해요.

엘레나 우리 장점은 주름이 아니에요. 용해죠. 그게 하위 연구예요.

노박 맞아요. 본 연구: 주름에서 동등. 하위 연구: 더 빨리 녹음.

그레이스 하위 연구엔 환자가 몇 명이에요?

노박 40명. 군당 20명. 양쪽 같은 응급 용량.

프리야 환자 40명. 차이를 보기에 충분해요?

절정·전환 — “Not worse” vs. “Better”

노박 동물 데이터만큼 차이가 크다면, 네. 충분해요.

노아 하나 반박해도 될까요? 본 연구에 대해서요?

노박 하세요.

노아 중요한 건 이거예요. “루마덤보다 나쁘지 않다”는 약한 메시지예요. 4년 동안 의사들을 만나 봤는데, “나쁘지 않다”에 흥분하는 사람은 아무도 없어요. 다들 “더 좋다”를 원해요.

엘레나 노아, 이건 과학이에요. 마케팅이 아니라.

노아 알아요. 하지만 결국엔 마케팅이 돼요. 누군가는 팔아야 하잖아요.

프리야 그럼 진실을 팔아. “같은 효과. 거기에 비상구까지.”

노박 그거 사실 강한 메시지예요. 그리고 두 부분 다 증명할 수 있고요.

마커스 “똑같고, 플러스.” 좋네. 간단하고.

노아 “같은 효과, 거기에 비상구.” 좋아요. 그건 팔 수 있어요.

엘레나 그리고 파크 박사 기억해요. “더 빠르다”는 측정이에요. 우린 측정값을 갖게 될 거예요.

노박 경고 하나요. 비열등성으로 설계하면 나중에 우월성을 주장할 수 없어요.

노아 우리 숫자가 더 좋아 보여도요?

노박 그래도요. 답을 보기 전에 질문을 정하는 거예요. 데이터가 나온 뒤에 질문을 바꾸면, 규제 당국은 여러분이 좋은 이야기를 찾아다녔다고 볼 거예요.

그레이스 그게 규칙이에요. 안 그러면 누구나 데이터를 본 뒤에 이야기를 고를 수 있잖아요.

프리야 3그룹처럼.

노아 3그룹처럼. 알았어. 그 교훈은 이미 배웠어.

노박 그럼 확정하죠. 1차: 6개월 비열등성. 2차: 12개월 지속력.

엘레나 그리고 핵심 2차: 하위 연구의 용해 속도.

노박 그리고 안전성. 모든 이상반응, 양쪽 군.

마커스 사이트는 몇 곳이었지?

그레이스 열다섯 곳. 레이첼 스타인 병원이 1번 사이트예요.

레오 첫 환자는 언제예요?

그레이스 2주 안에 답변하고 사이트 교육이 끝나면 11월 중순이요.

노박 최종 프로토콜을 월요일까지 보내 주세요. 표본 크기를 다시 계산해 볼게요.

마무리 — 오후 6시, Richard의 전화

노아 리처드, 좋은 소식이에요. IDE가 승인됐어요. 조건 세 개와 함께요.

리처드 조건은 정상이에요. 축하해요. 첫 환자는 언제예요?

노아 11월 중순이요. 환자 300명. 사이트 열다섯 곳.

리처드 그리고 임상 비용은 1,260만인데, 남은 돈은 400만 정도죠. 그러니까 모든 게 완벽하게 흘러가도, 임상이 끝나기 한참 전에 돈이 떨어져요.

노아 알아요. 400만 정도요. 네.

리처드 그럼 내가 무슨 말 할지 알겠네요.

노아 시리즈 A.

리처드 시리즈 A를 지금 시작해요. 첫 환자 다음이 아니라. 지금.

노아 왜 지금이요? 석 달 뒤면 데이터가 더 생길 텐데요.

리처드 돈은 필요하지 않을 때 모으는 거예요. 투자자들은 절박함을 귀신같이 알아채거든요. 정말 필요할 땐 이미 늦고, 가격도 그쪽이 정하게 돼요.

노아 얼마를 모아야 할까요?

리처드 임상을 끝내고 PMA를 제출할 만큼요. 2,500만 달러.

노아 2,500만. 노스게이트가 리드하실 건가요?

리처드 우리도 투자는 해요. 하지만 더 큰 펀드가 리드해야 해요. 벌써 두 곳이 당신들에 대해 전화했어요.

노아 두 곳이라. 그럼 최고의 덱을 가져가야겠네요.